ONEMA-POP-023 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-023 — Apoio ao Aleitamento — Fissuras Mamilares
e Ingurgitamento

1. Identificação institucional

REVISÃO TÉCNICA DO RT

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a abordagem de apoio ao aleitamento — fissuras mamilares e ingurgitamento em atendimento domiciliar ou digital, conforme a pertinência. Não substitui avaliação médica ou atendimento de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e treinado. Puérperas com dor, fissuras e ingurgitamento durante aleitamento; excluir mastite e abscesso. Contraindicado manter cuidado eletivo quando presentes sinais de emergência ou quando o procedimento exceder a competência/estrutura disponível.

4. Materiais e fornecimento

Enfermeiro: luvas se necessário, material educativo, compressas limpas; paciente: recipiente limpo para expressão quando indicado, absorventes e suporte de amamentação.

5. Avaliação e preparo

Avaliar pega, posição, frequência, transferência de leite, diurese e peso do bebê, febre materna, eritema focal e dor.

6. Execução técnica numerada

1. Observar uma mamada com consentimento e privacidade, incluindo posicionamento e alinhamento do bebê.

2. Avaliar abertura oral, abocanhamento da aréola, deglutição e dor durante sucção.

3. Corrigir pega e posicionamento com apoio prático, sem manipulação dolorosa das mamas.

4. Para fissura, avaliar trauma e orientar higiene habitual; evitar antissépticos irritantes e fricção.

5. Para ingurgitamento, favorecer mamadas responsivas e expressão manual apenas até conforto/pega, sem

hiperestimular produção.

6. Se edema areolar dificultar pega, orientar medidas suaves para facilitar abocanhamento; evitar massagem

profunda.

7. Verificar sinais de mastite: febre, mal-estar, eritema focal progressivo, dor intensa; encaminhar para avaliação.

8. Reavaliar dor, pega e sinais de hidratação/ingestão do bebê e registrar plano de retorno.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Febre persistente, suspeita de abscesso, bebê letárgico ou desidratado: avaliação presencial urgente.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar continuidade do aleitamento quando clinicamente possível e buscar apoio especializado em lactação.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa e histórico, avaliação e sinais vitais pertinentes, achados objetivos, cada etapa executada e resposta, orientações, escalonamento/contatos, plano de retorno, identificação e assinatura do enfermeiro. Fotos somente com consentimento específico.

10. Referências rastreáveis

 Academy of Breastfeeding Medicine — Clinical Protocol #36, Mastitis Spectrum — https://www.bfmed.org/protocols

NOTA DE CONTROLE: referências identificadas e parcialmente conferidas; adequação à legislação brasileira, protocolos locais e instruções de fabricante deve ser analisada pelo RT.